

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN

NO DOKUMEN	:	UDDP- MK-L2-004
VERSI	:	003
TANGGAL BERLAKU	:	26 MARET 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	26 MARET 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Shaffa Auliya Hawwa, A.Md. Kes. Staf Pelulusan Produk UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 6 Maret 2025
Diperiksa oleh MASTER Frida Rosita, S.Si, M.Biomed. Kasubid Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 17 Maret 2025 DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si. Kasubid Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 20 Maret 2025
Disahkan oleh dr. Srihartaty, M.Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 25 Maret 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman 1 dari 8 Nomor UDDP-MK-L2-011 Versi 003 Tgl. berlaku: 26 Mar 2025 Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menggambarkan proses tentang:

- 1.1 Pelaporan dan penatalaksanaan insiden yang ditemukan pada bagian teknis (rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah, proses pengolahan, pengujian darah, penyimpanan dan distribusi) maupun bagian non teknis yang selalu harus dipantau, diselidiki diperbaiki dan didokumentasikan
- 1.2 Penilaian tingkat risiko insiden yang terjadi dan dampaknya terhadap mutu, keamanan dan efektivitas darah dan komponen darah
- 1.3 Pengidentifikasian dan analisis akar penyebab serta penyiapan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) memadai yang harus diambil untuk menghindari keberulangan penyimpangan yang sama

2. RuangLingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Unit Donor Darah Pusat (UDDP) untuk melaporkan insiden atau kejadian penyimpangan dan mencatatnya untuk diambil Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP).

Laporan Insiden harus meliputi:

- 2.1. Prosedur yang tidak diikuti dan terdapat potensi yang akan berdampak kepada kualitas dan keamanan staf, donor atau komponen darah dan produk yang dihasilkan oleh UDDP
- 2.2. Kesalahan sistem, bahan, peralatan.
- 2.3. Kesalahan lingkungan terkait dengan standar yang telah ditetapkan (suhu, kelembapan, kebersihan, keamanan).
- 2.4. Keluhan pelanggan
- 2.5. Kejadian berat selama donor darah (reaksi transfusi dan efek samping donor darah yang berat)
- 2.6. Produk yang tidak sesuai spesifikasi,
- 2.7. Kebutuhan untuk deviasi/penyimpanngan yaang terencana: di tengah rencana yang sudah dibuat, perlu dilakukan tindakan lain yang setara dari rencana awal
- 2.8. Kinerja pemasok atau permasalahan pemasok.

Pencatatan TPP harus dimasukkan dalam Laporan Insiden dan semua pencatatan digunakan untuk kejadian berikut:

- 2.9 Investigasi dan rencana *Corrective and Preventive Action* (CAPA) diperlukan jika insiden yang terjadi itu kompleks dan melibatkan banyak bidang
- 2.10 Permasalahan yang terjadi dirasa tidak serius, namun terus berulang terjadi sehingga dapat berdampak serius.
- 2.11 Data atau pengawasan yang menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya permasalahan serius, dimana hal ini belum terjadi, namun berpotensi terjadi di masa yang akan datang.



UNIT DONOR DARAH PUSAT

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman 2 dari 8
Nomor UDDP-MK-L2-011
Versi 003
Tgl. berlaku: 26 Mar 2025
Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027

3 Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 1.17

Setiap penyimpangan terhadap SPO, proses tervalidasi, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau persyaratan lain yang terkait mutu hendaklah dicatat dan diselidiki. Dampak yang potensial terhadap mutu produk yang menyimpang, atau terhadap produk lainnya, hendaklah dievaluasi.

3.2 Butir 1.18

Evaluasi penyebab penyimpangan dan proses yang kemungkinan berkaitan dengan penyimpangan hendaklah didokumentasikan. Pengkajian dan persetujuan kelengkapan penyelidikan sampai tuntas hendaklah didokumentasikan oleh pemastian mutu.

3.3 Butir 1.19

Semua penyimpangan dan ketidaksesuaian hendaklah dimasukkan dalam suatu sistem yang memungkinkan pengkajian data secara tepat. Pengkajian data hendaklah dilaksanakan secara berkala dengan cara yang memungkinkan untuk penelusuran dan pembuatan tren data yang memudahkan perbaikan proses.

3.4 Butir 1.20

Penanganan penyimpangan dan ketidaksesuaian hendaklah ditetapkan secara tertulis. Hendaklah diambil tindakan dalam jangka waktu yang wajar untuk menghindari dampak pada produk lain yang dibuat di unit yang sama.

3.5 Butir 1.21

Dalam keadaan tertentu, suatu produk mungkin dapat diluluskan setelah dilakukan evaluasi penyimpangan. Dokumentasi hendaklah mencakup justifikasi atau alasan pelulusan produk yang dibuat menyimpang dari persyaratan, dan hendaklah ditandatangani oleh Manajer Pemastian Mutu.

3.6 Setiap kesalahan, insiden, ketidaksesuaian, kegagalan, penyimpangan dan lainnya harus segera didokumentasikan dan diinvestigasi terhadap akar penyebab masalahnya. Tindakan perbaikan harus segera diambil untuk memperbaiki segera masalah ini, kemudian ditentukan juga tindakan perbaikan dan pencegahannya (TPP) agar tidak berulang di masa yang akan datang.

3.7 Masa penyelesaian Insiden:

- | | | |
|-------|---|---|
| 3.7.1 | Insiden sangat rendah
(<i>insignificant</i>) | : Tindakan perbaikan dilakukan pada saat itu juga |
| 3.7.2 | Insiden rendah (minor) | : Tindakan dilakukan jika diperlukan dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan yang sudah ada |
| 3.7.3 | Insiden sedang (moderat) | : 6 minggu sejak tanggal TPP dimulai |
| 3.7.4 | Insiden tinggi (mayor) | : 4 minggu sejak tanggal TPP dimulai |
| 3.7.5 | Insiden sangat tinggi
(kritikal) | : 2 minggu sejak tanggal TPP dimulai |

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman 3 dari 8 Nomor UDDP-MK-L2-011 Versi 003 Tgl. berlaku: 26 Mar 2025 Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

4 Referensi

- 4.1 PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Peraturan Kepala No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis.

5 Definisi dan Singkatan

- 5.1 Insiden adalah penyimpangan terhadap semua kejadian yang tidak direncanakan ataupun pada kondisi tertentu diprediksi akan terjadi potensi penyimpangan selama dan/atau sesudah proses pengolahan komponen darah
- 5.2 TPP adalah Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (*Corrective and Preventive Action*)
- 5.3 Sangat rendah (*insignificant*) adalah ketidaksesuaian yang berdampak kecil sehingga tidak perlu dilakukan tindakan atau *monitoring*
- 5.4 Rendah (*minor*) adalah ketidaksesuaian yang tidak berdampak pada produk namun terkait dengan ketidaksesuaian terhadap standar atau SPO. Signifikasi dari ketidaksesuaian minor mungkin hanya menjadi perhatian bagi pihak terkait internal
- 5.5 Sedang (*moderate*) adalah ketidaksesuaian yang berdampak pada produk namun terkait dengan ketidaksesuaian terhadap standar atau SPO. Signifikasi dari ketidaksesuaian sedang, menjadi perhatian bagi pihak terkait internal
- 5.6 Tinggi (*mayor*) adalah ketidaksesuaian yang mungkin dapat membuat sebuah produk tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan atau potensial dapat mengakibatkan efek samping pada penerima produk
- 5.7 Sangat tinggi (*kritikal*) adalah ketidaksesuaian yang berefek secara signifikan terhadap keamanan, efikasi serta kualitas dari sebuah produk dan berpotensi dapat menimbulkan kesalahan yang fatal dan memerlukan perbaikan segera
- 5.8 Pelapor adalah pihak yang melaporkan terhadap hasil temuan ketidaksesuaian
- 5.9 Responder adalah pihak yang merespon hasil temuan ketidaksesuaian, mencari akar penyebab dan melakukan penanganan
- 5.10 Status "Karantina" adalah penyimpanan sementara kompoenn darah, BHP ataupun barang di suhu tertentu untuk diselidiki penyebab insiden hingga dapat ditentukan statusnya
- 5.11 Status "Tarik" adalah proses penarikan komponen darah, BHP ataupun barang di suhu tertentu yang mengalami penyimpangan sehingga tidak dapat digunakan sesuai standar
- 5.12 Status "Buang" adalah tindakan yang dilakukan setelah dilakukan penarikan komponen darah, BHP atau barang di suhu tertentu yang mengalami penyimpangan
- 5.13 Status "Rilis" adalah tindakan yang dilakukan untuk merilis komponen darah, BHP ataupun barang di suhu tertentu setelah dinyatakan layak untuk digunakan

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman 4 dari 8
Nomor UDDP-MK-L2-011
Versi 003
Tgl. berlaku: 26 Mar 2025
Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027

6 Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manajer Kualitas	• Mengesahkan SPO Pelaporan dan Penanganan Insiden • Memberikan persetujuan laporan insiden dan rencana perubahan untuk insiden mayor dan kritikal • Melakukan tinjauan manajemen terhadap Laporan Insiden, Rencana Perubahan dan TPP yang disusun bersama dengan Kepala Sub Bidang Kontrol Dokumen, Kepala Bidang Pemastian Mutu, dan Kepala Bidang yang terkait • Memberikan persetujuan untuk penutupan laporan insiden apabila TPP dan rencana perubahan telah dilakukan
Kepala Sub Bidang Pemastian Mutu	• Memastikan bahwa semua tindakan perbaikan dan pencegahan telah diambil • Mengkaji ulang kelengkapan dan kesesuaian laporan bersama dengan Manajer Kualitas
Kepala Sub Bidang Kontrol Dokumen	• Menyediakan formulir dan nomor registrasi pelaporan dan penanganan insiden • Berkoordinasi dengan bidang terkait untuk pembuatan laporan • Memutuskan apakah memerlukan pencatatan TPP
Kepala Bidang	• Melakukan investigasi bersama dengan petugas di masing-masing bidang atau bidang terkait lainnya sesuai dengan jenis penyimpangannya • Menunjuk penanggung jawab investigasi untuk pelaporan dan penanganan insiden • Menunjuk ketua dan tim pencatatan TPP (apabila diperlukan) bersama dengan Manajer Kualitas • Ikut serta dalam melakukan rapat tinjauan manajemen terhadap Laporan Insiden, Rencana Perubahan dan TPP yang disusun • Menganalisa penilaian dampak risiko bersama dengan pelapor/investigator
Responder (Penanggung jawab terkait)	• Dinominasikan oleh Kabid yang bertanggungjawab untuk melalui masalah yang ditemukan • Melakukan investigasi terhadap akar penyebab • Melakukan penilaian dampak risiko bersama dengan Kepala Bidang terkait



UNIT DONOR DARAH PUSAT

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman 5 dari 8
Nomor UDDP-MK-L2-011
Versi 003
Tgl. berlaku: 26 Mar 2025
Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027

Peran	Tanggung Jawab
	• Memberitahukan Manajer Kualitas dan Kepala dengan segera jika hasil penilaian dampak berupa Mayor atau Kritis • Melakukan tindakan perbaikan segera terhadap komponen yang terkait • Menentukan tindakan yang sesuai dan lengkapi Rencana Perubahan jika diperlukan • Memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan konfirmasi tindakan perbaikan telah lengkap
Reporter/Pelapor (Petugas/Kepala Bidang yang menemukan insiden)	• Melaporkan insiden kepada Kepala Bidang terkait dan Manajer Kualitas • Meminta formulir dan nomor registrasi pelaporan dan penanganan insiden kepada Sub Bidang Kontrol Dokumen • Membuat Laporan Insiden

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

7. Prosedur

- 7.1. Identifikasi terjadinya insiden dan melaporkan secara lisan oleh petugas kepada Kepala Bidang bersangkutan, Kepala Bidang segera menghentikan kegiatan yang terkait jika insiden berupa mayor/kritis
- 7.2. Pisahkan produk atau identifikasi bagian yang terkait insiden. Apabila insiden berdampak pada produk, maka beri tanda status yang jelas pada produk misalnya status: "karantina"
- 7.3. Isi formulir pelaporan dan penanganan insiden
 - 7.3.1 Dapatkan nomor registrasi Laporan Insiden dari Sub Bidang Kontrol Dokumen
 - 7.3.2 Lengkapi Kegiatan 1 (satu) Pelaporan Insiden pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden, yang menjelaskan:
 - Tanggal insiden dan Bidang tempat terjadinya insiden ditemukan
 - Proses apa yang ditunjukkan ketika insiden ditemukan (jika ada)
 - Apa yang terjadi dan tindakan perbaikan apa yang telah diambil
- 7.4 Beri tanda tangan dan tanggal pada kolom di Kegiatan 1 (satu) oleh Pelapor
- 7.5 Serahkan Laporan Insiden ke Kepala Bidang terkait yang harus menyelesaikan dan merespon masalah atau insiden yang ada
- 7.6 Lakukan evaluasi dan penelusuran penyebab insiden dengan berbagai cara untuk mendapatkan akar penyebab dari penyimpangan
- 7.7 Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang menetapkan atau menunjukkan apakah memerlukan Pencatatan TPP atau tidak sebelum menunjuk seorang Responder dan Pimpinan TPP
 - 7.7.1 Reviue kegiatan 2 (dua)
 - 7.7.2 Nominasi Responder jika insiden yang ditemukan hanya melibatkan 1 (satu) bidang saja
 - 7.7.3 Nominasi Pimpinan TPP dan timnya jika:

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman 6 dari 8 Nomor UDDP-MK-L2-011 Versi 003 Tgl. berlaku: 26 Mar 2025 Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- Investigasi dan rencana TPP diperlukan jika insiden yang terjadi itu kompleks dan melibatkan banyak bidang
- Permasalahan yang terjadi dirasa tidak serius, namun terus berulang terjadi sehingga dapat berdampak serius
- Data atau pengawasan yang menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya permasalahan serius, dimana belum terjadi, namun berpotensi terjadi dimasa yang akan datang

7.8 Penilaian Dampak

Penilaian dampak dan tindakan terhadap objek yang terdampak yang dilakukan oleh Responder terpilih/Kepala Bidang

7.8.1 Lengkapi dan isi kegiatan 3 (tiga) Penilaian Dampak pada Formulir Pelaporan dan Penanganan insiden

7.8.2 Nilai dampak dari insiden dengan menggunakan Tabel pada kegiatan 3 dan tentukan tingkat keparahan dari insiden dan cara penemuannya

7.8.3 Beritahu kepada Kepala dan Manajer Kualitas sesegera mungkin jika hasil penilaian dampak berupa "mayor" atau "kritis"

7.8.4 Tentukan perbaikan sesuai dengan penilaian dampak terhadap objek tersebut. Apabila objek yang terdampak adalah komponen darah, maka tindakan yang diambil yaitu:

7.8.4.1 Konfirmasi jumlah dan jenis komponen darah yang terkena dampak

7.8.4.2 Tentukan tindakan:

- Karantina komponen darah (biasanya dilakukan sesegera mungkin dan ketika penilaian dampak sedang bertanggung jawab)
- Tarik komponen terkait (jika sudah dirilis ke RS)
- Buang komponen terkait
- Rilis komponen terkait (alasan yang mendukung penggunaan komponen itu harus ditulis dalam laporan)

7.8.5 Tanda tangan untuk konfirmasi bahwa tindakan perbaikan terhadap komponen telah dilakukan

7.8.6 Pastikan bahwa kegiatan 3 telah dilengkapi

7.8.7 Lakukan kajian risiko sesuai dengan SPO Manajemen Risiko Mutu (UDDP-MK-L2-002)

7.9 Investigasi dan Tindakan Perbaikan Pencegahan

Investigasi dilakukan oleh Responder terpilih yang juga akan menentukan tindakan perbaikan pencegahan yang dilakukan

7.9.1 Lakukan investigasi untuk menemukan akar penyebab dari insiden dan lengkapi kolom pertama kegiatan 4 (empat) Investigasi dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden.

7.9.2 Sisipkan salinan dokumen atau bukti lainnya jika diperlukan

7.9.3 Tentukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) yang akan diambil untuk memperbaiki masalah saat ini dan mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang. Lengkapi kolom kedua dari kegiatan 4 (empat)

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman 7 dari 8 Nomor UDDP-MK-L2-011 Versi 003 Tgl. berlaku: 26 Mar 2025 Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

7.9.4 Apabila Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) akan melibatkan perubahan mayor, lengkapi Formulir Rencana Perubahan (UDDP-MK-L4-008) dan merujuk kepada SPO Pengendalian Perubahan (UDDP-MK-L2-003). Masukkan Nomor Rencana Perubahan pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden

7.9.5 Dapatkan persetujuan untuk rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dari Manajer Kualitas apabila hasil penilaian dampak berupa mayor atau kritikal. Apabila dampak berupa minor, tandai dengan N/A

7.9.6 Pastikan bahwa kegiatan 4 (empat) telah dilengkapi

7.10 Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)

Responder mengkonfirmasi bahwa semua Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) telah dilakukan dan semua dokumentasi telah lengkap

7.10.1 Lengkapi kolom kesimpulan dari tindakan yang diambil pada kegiatan 5 (lima)

7.10.2 Sisipkan bukti penyelesaian TPP

7.10.3 Jika terdapat rencana perubahan, lengkapi dan sisipkan Formulir Rencana Perubahan pada Pelaporan dan Penanganan Insiden

7.10.4 Beri tanda tangan dan tanggal pada kolom kegiatan 5 (lima)

7.10.5 Periksa laporan secara keseluruhan untuk konfirmasi kelengkapan

7.10.6 Ajukan kepada Manajer Kualitas untuk persetujuan penutupan laporan insiden



7.11 Penutupan Laporan

Setujui dan tanda tangani Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden (UDDP-MK-L4-010) oleh Manajer Kualitas atau orang yang diberi wewenang setelah melakukan:

7.11.1 Review Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden dan sisipkan bukti untuk kelengkapan dan kesesuaian

7.11.2 Review untuk mengecek kelengkapan dan kesesuaian jika terdapat rencana perubahan

7.11.3 Tanda tangani Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden dan Formulir Rencana Perubahan jika sudah sesuai dan lengkap

7.11.4 Perbaharui Daftar Registrasi Pelaporan dan Penanganan Insiden dan Registrasi Rencana Perubahan, dan Formulir Registrasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) jika digunakan.

7.11.5 Laporkan hasil akhir Laporan Insiden, Rencana Perubahan dan TPP pada Manajemen menggunakan Laporan Tinjauan Manajemen

8. Dokumen Terkait

8.1 SPO Pengendalian Perubahan

(UDDP-MK-L2-003)

8.2 SPO Manajemen Risiko Mutu

(UDDP- MK-L2-002)

8.3 SPO Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

(UDDP-MK-L2-005)



UNIT DONOR DARAH PUSAT

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN**

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman 8 dari 8
Nomor UDDP-MK-L2-011
Versi 003
Tgl. berlaku: 26 Mar 2025
Tgl. kaji ulang: 26 Mar 2027

9 Lampiran

9.1 Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden	(UDDP-MK-L4-010)
9.2 Daftar Registrasi Pelaporan dan Penanganan Insiden	(UDDP-MK-L4-038)
9.3 Registrasi Rencana Perubahan	(UDDP-MK-L4-009)
9.4 Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	(UDDP-MK-L4-011)

10 Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Januari 2021	PerKa No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis	Dokumen baru
002	17 Februari 2023	PerKa No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis CPOB	- Perubahan tanggal berlaku dan kaji ulang - Revisi hasil investigasi BPOM
003	26 Maret 2025	PerKa No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01	- Menyisipkan poin pengkajian manajemen risiko sesuai dengan SPO Manajemen Risiko - Perubahan kata "Direktur" menjadi "Kepala" - Perubahan kalimat dalam peran dan tanggung jawab sesuai dengan format yang berlaku - Perubahan struktur organisasi - Penambahan Peran dan Tanggung jawab dengan menambahkan yang diberi wewenang sebagai Pj Kepala dan Manajer Kualitas